



EMERGENCY OPERATIONS CENTER — PERIODE 31 JULY 2026

LAPORAN INFOGRAFIS EOC KEMENKES RI: EKSEKUTIF KRISIS KESEHATAN KEBENCANAAN

Analisis Situasi Kebencanaan, Dampak Korban, dan Mobilisasi Kesiapsiagaan Darurat

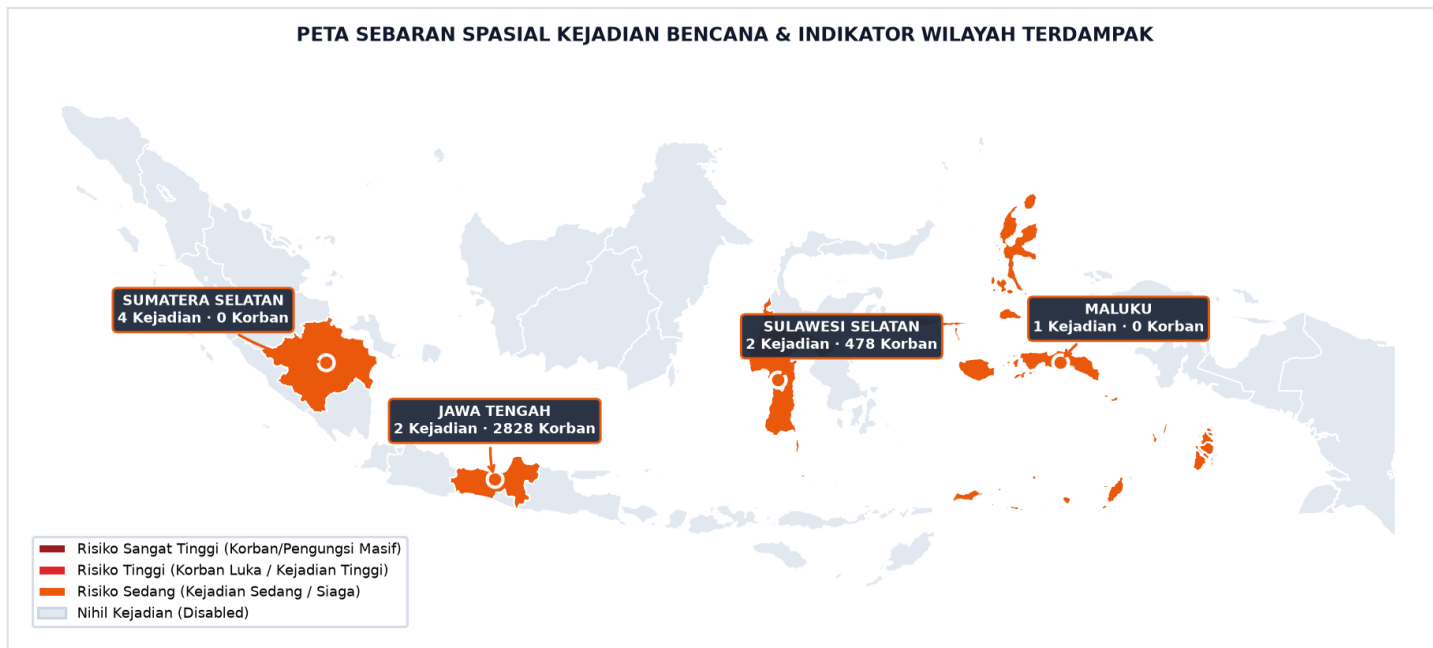
PERIODE PEMANTAUAN
31 July 2026 (24 Jam)

CAKUPAN
38 Provinsi

PEMBARUAN TERAKHIR
01 August 2026, 05:00 WIB

DITERBITKAN OLEH
Pusat Krisis Kesehatan
Kemenkes RI

PETA SPASIAL SEBARAN BENCANA & ANOTASI WILAYAH TERDAMPAK



Sintesis Spasial Sebaran Bencana Berdasarkan analisis geospasial EOC Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI tanggal **31 July 2026**, sebaran kejadian bencana terkonsentrasi di wilayah **JAWA TENGAH** dan sekitarnya. Kluster wilayah terdampak langsung mendapatkan pengawasan ketat untuk menjamin kontinuitas pelayanan kesehatan emergensi.

ENAM INDIKATOR UTAMA KRISIS KESEHATAN NASIONAL

9 TOTAL KEJADIAN BENCANA Kejadian tercatat, seluruh Indonesia	0 KORBAN MENINGGAL DUNIA Jiwa	1.422 KORBAN LUKA (BERAT & RINGAN) Jiwa
0 KORBAN HILANG Jiwa, dalam pencarian aktif	235 PENGUNSI DI POSKO Jiwa, tersebar di titik pengungsian	1.649 PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS Jiwa, akumulasi nasional

RINGKASAN EKSEKUTIF ANALISIS SITUASI & KOORDINASI MULTI-SEKTOR

Berdasarkan pemantauan 24 jam EOC Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI tanggal **31 July 2026**, terkonfirmasi eskalasi **9 kejadian bencana** di wilayah nasional dengan rincian profil: **Kebakaran Hutan dan Lahan: 7 Kejadian (Wilayah: MALUKU, SULAWESI SELATAN, SUMATERA SELATAN); Banjir: 2 Kejadian (Wilayah: JAWA TENGAH)**. Penanganan emergensi kesehatan difokuskan pada penanggulangan fatalitas (**0 jiwa meninggal dunia, CFR: 0%**) serta pertolongan medis cepat terhadap **1422 jiwa korban luka-luka** dan pencarian aktif **0 jiwa korban**

hilang dengan akumulasi **1649 jiwa penduduk terdampak**.

Sebanyak **235 jiwa pengungsi** saat ini terdata berada di posko-posko pengungsian darurat. Tim Klaster Kesehatan Kemenkes RI bekerja sama dengan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi dan BPBD setempat mendistribusikan logistik obat-obatan emergensi, paket sanitasi air bersih, dan kit higiene untuk memitigasi risiko potensi kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular seperti ISPA dan Diare sesuai standar WHO.

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI menginstruksikan aktivasi penuh Tim Medis Darurat (Emergency Medical Team / EMT Tipe 1) di wilayah terdampak utama serta menyiagakan jejaring Rumah Sakit Rujukan Regional. Integrasi pemantauan cuaca ekstrem BMKG dan koordinasi evakuasi medis terpadu bersama Basarnas dan TNI/Polri terus dilakukan secara berkelanjutan.

Status Komando & Arahan: Instruksi Komando EOC: Seluruh Tim Medis Darurat (EMT) dan Klaster Kesehatan Wilayah Terdampak agar tetap siaga 24 jam serta melaporkan secara berkala pergerakan data epidemiologi.

A. TABEL DISTRIBUSI WILAYAH KEJADIAN BENCANA (31 JULY 2026)

Tabel di bawah ini menyajikan sebaran wilayah terdampak kejadian bencana pada tanggal 31 July 2026 beserta rincian kabupaten/kota dan total korban.

NO.	PROVINSI TERDAMPAK	TOTAL KEJADIAN	TOTAL KORBAN & PENGUNGS	KABUPATEN / KOTA TERDAMPAK
1	JAWA TENGAH	2 Kejadian	1414 Terdampak, 1414 Luka	KOTA SEMARANG
2	SULAWESI SELATAN	2 Kejadian	235 Terdampak, 235 Pengungsi, 8 Luka	ENREKANG, KOTA MAKASSAR
3	SUMATERA SELATAN	4 Kejadian	0 Korban Dilaporkan	KOTA PALEMBANG, MUARA ENIM, OGAN KOMERING ILIR
4	MALUKU	1 Kejadian	0 Korban Dilaporkan	SERAM BAGIAN TIMUR

B. STATUS & KESIAPSIAGAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

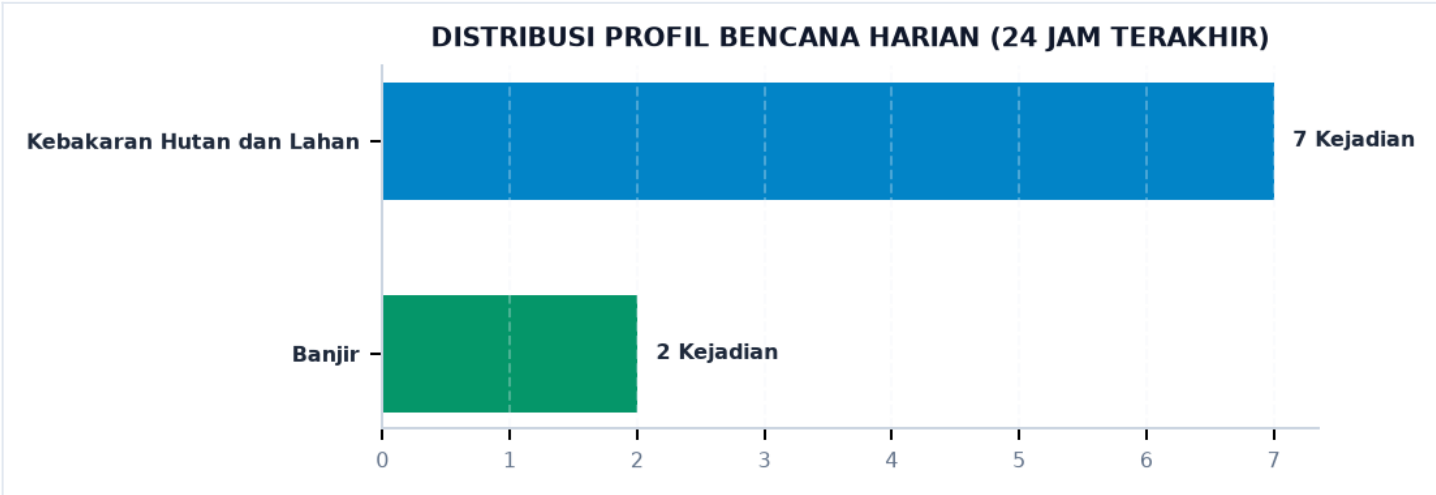
Penilaian kesiapsiagaan fasyankes menunjukkan kesiapan RS Siaga dan Puskesmas di wilayah terdampak dalam menampung rujukan korban dengan dukungan logistik kesehatan pusat.

RUMAH SAKIT SIAGA 140 RADIUS 25 KM BENCANA	PUSKESMAS SIAGA 265 RADIUS 25 KM BENCANA	KLINIK & PUSTU SIAGA 979 RADIUS 25 KM BENCANA	FASKES RUSAK (B/S/R) 0 / 0 / 0 NIHIL KERUSAKAN
---	---	--	---

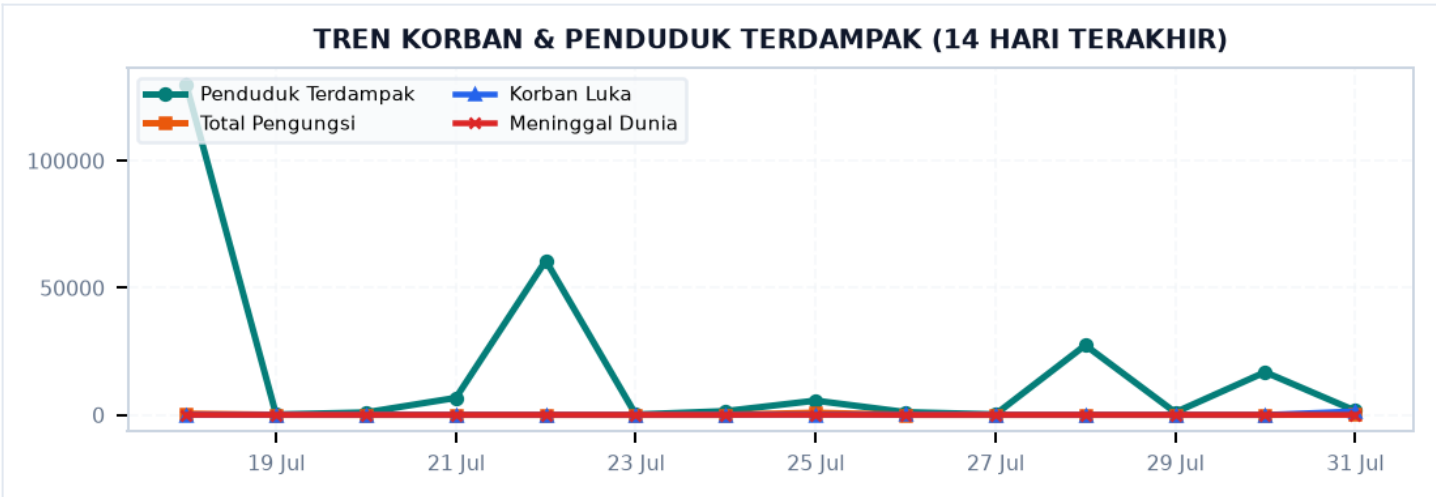
Catatan Komando Faskes: Instruksi pemantauan kesiapan IGD 24 jam dan koordinasi jalur rujukan SPGDT di RS rujukan penyangga.

A. TREN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI & DAMPAK KEBENCANAAN (14 HARI)

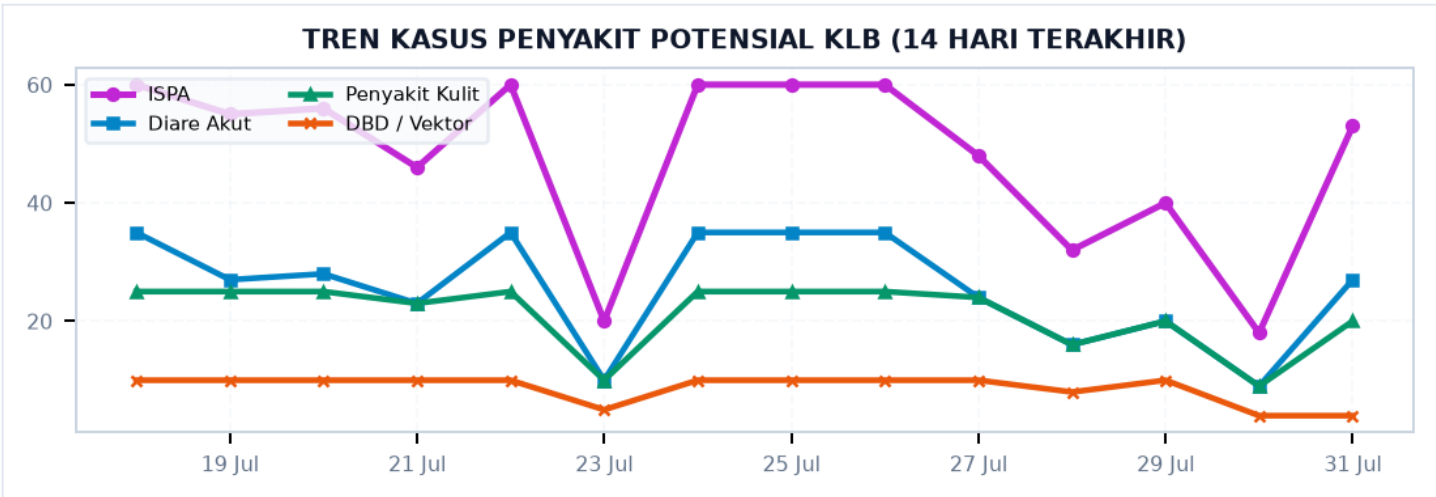
Evaluasi pergerakan indikator kebencanaan dan surveilans kesehatan selama 14 hari terakhir menunjukkan dinamika situasi sebagai berikut:



Analisis Profil Jenis Bencana Grafik menunjukkan distribusi jenis bencana harian di mana eskalasi didominasi oleh jenis bencana spesifik pada tanggal 31 July 2026.



Analisis Tren Korban & Populasi Terdampak (14 Hari) Grafik menunjukkan tren fluktuasi korban dan penduduk terdampak selama 14 hari terakhir sebagai acuan alokasi logistik.



Analisis Tren Kasus Penyakit Potensial KLB (14 Hari) Grafik menunjukkan surveilans tren penyakit potensial KLB (ISPA, Diare, Kulit) di lokasi pengungsian.

B. PROTOKOL TAKTIS TIM MEDIS DARURAT (EMERGENCY MEDICAL TEAM)

Sintesis Analisis Kecerdasan Buatan (EOC AI Engine — Gemini 2.5 Flash): Protokol penugasan taktis di bawah ini disusun secara otomatis oleh model AI Gemini 2.5 berdasarkan integrasi indikator morbiditas korban, data kejadian harian, ketersediaan faskes siaga, dan pemodelan risiko kebencanaan untuk percepatan komando penanganan krisis kesehatan.

Berdasarkan sintesis analitik EOC dan evaluasi situasi bencana tanggal 31 July 2026, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI menginstruksikan pelaksanaan langkah respons terpadu:

- 1 Aktivasi & Kesiapsiagaan EMT Tipe 1 (Fase Preventif / Siaga)**
Menyiagakan tim mobile EMT Tipe 1 di tingkat kabupaten/kota untuk deteksi dini dan kesiapan respon cepat kebencanaan.
- 2 Kesiagaan Rumah Sakit Rujukan Regional & SPGDT**
Memastikan kesiapan IGD 24 jam dan ketersediaan buffer stock obat emergensi di seluruh RS rujukan regional.
- 3 Penguatan Surveilans SKDR/EWARS Berkelanjutan**
Mengoptimalkan sistem pelaporan surveilans berbasis indikator dan kejadian untuk mengantisipasi potensi KLB penyakit menular.

Dokumen resmi Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI ini diterbitkan sebagai rujukan strategis pimpinan dan instansi terkait dalam penanganan krisis kesehatan.

DISAHKAN
SECARA DIGITAL
EOC KEMENKES RI
01 August 2026

Kepala Pusat Krisis Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI